# 基金申请 · 一页提纲（项目核心）

2026-11-02 | 依据：《基金申报要求》《研究方案》v1.2、《统计分析计划》v1.2、样本量材料

**红线**：合成数据不得写成预实验；文献数值不得拼接为本项目效应量；事实卡"医生未签署"不得改为已签署；未做系统证据覆盖核查，不写"覆盖有限/缺乏证据"等定论；最终样本量申请时尚未确定。

## 申报要求

栏目 8 项：科学问题 300 字 / 背景 600 字 / 目标≤3 项 / 设计与统计 800 字 / 技术路线图 / 风险与替代 / 进度及预算 / 伦理与数据治理。周期 12 个月；经费上限 10 万元（规划假设）；评审重点：问题价值、方法合理性、可行性。

## 一个科学问题（299 字，已达标）

社区老年（≥60 岁）已确诊高血压人群中，规范化家庭血压自测支持（不主导用药滴定）联合常规管理，6 个月诊室收缩压能否进一步下降？Uhlig 2013 提示单纯自测 6 个月净差约 −3.9 mmHg，但证据以西方人群为主、12 个月不再显著；TASMINH4 效应含滴定、无法归因于"测量"。中文社区老年人群针对上述问题的直接随机对照证据覆盖程度尚需系统核查；纯测量效应维持性与沾染影响均为本项目关注的问题。

## 创新点（3 项）

1. **问题定位**：面向中文社区老年人群、以 6 个月诊室收缩压为主要结局的个体随机对照试验，回应本项目关注的应用问题；该人群直接证据覆盖程度尚待系统核查确认。
2. **设计特点 · 沾染预设测量**：入组与 6 个月时点记录两组自购血压计持有情况并纳入解释——设计特点而非新方法，价值在积累该人群沾染实测数据。
3. **设计特点 · 参数显式化敏感性框架**：可重跑脚本呈现 δ×SD 矩阵，参数全部标注来源与状态——统计设计特点而非方法学创新，价值在透明可复核。

## 研究目标（3 项）

① 主要：6 个月诊室收缩压组间差（调整基线、年龄、社区）及 95% CI；② 次要与过程：达标比例（阈值【待确认】）、依从、失访、两组血压计持有（沾染指标）、不良事件（不作确证性终点）；③ 方法学：积累基线分布、筛查—入组转化率、招募与失访率（SD、r、效应为纵向参数，随访后确认）。

## 设计与随机化（统一口径）

前瞻性、平行组、个体随机对照试验，两家城市社区【待确认】；**每个社区内均按 1:1 随机分入干预组和对照组，按社区分层**；测量者设盲，揭盲前 SAP 定稿。样本量按 δ（3/4/5）×SD（12/15/18）敏感性矩阵呈现 9 种组合（含脱落 15% 后约 216 – 1332 例）。

## 技术路线与可行性

准备（1 – 2 月：伦理、协议、设备、SOP、参数核实与样本量重算）→ 招募（3 – 4 月：筛查、知情、基线、分层个体随机）→ 随访（3 – 10 月：第 3、6 个月访视；每周核对入组进度）→ 结题（11 – 12 月：锁定、按 SAP 分析、结题）。周期账面可行（2+2+6+2），但招募窗口仅约 2 个月，月入组需求 108 – 666 人/月【社区能力待核实】；进度落后即触发周期/规模/资源重新论证，不得直接下调样本量。

## 研究基础与参数来源

已具备：方案 v1.2、SAP v1.2、可重跑样本量脚本与敏感性矩阵、事实卡 F01 – F10（AHA 来源核对、医生未签署）、五项文献核对记录。合作：拟依托两家城市社区【机构信息待确认】。参数：α=0.05、power=0.80、1:1、脱落 15% 为项目设定；δ=−3.9（Uhlig 摘要）、SD 16.1 – 16.7（TASMINH4 全文）仅各自情境参考；沾染率、r 无数据未纳入计算。

## 样本量与预算状态

**申请时最终样本量尚未确定**；336 例仅为预算测算情景（δ=4/SD=12 或 δ=5/SD=15 组合，独立重算总计 93,878 元、占上限 93.9%），规模须经敏感性矩阵与预算规模联动测算联合锁定——10 万元内仅 216/336 例两档可支撑。

## 伦理要点

实施前报伦理委员会审查批准【委员会信息待确认】；**风险级别拟作为最小风险研究提交伦理委员会评估判定**；书面知情同意；数据去标识化、加密分离存储；结果无论方向均按预设 SAP 报告。

## 缺项（详见《待补充材料清单》）

两社区机构信息与名册；设备询价与人力成本；δ 与 SD 最终依据；达标阈值与测量频次；随机化细节与伦理委员会；事实卡临床签署；团队 CV；证据覆盖系统核查报告。